# HELP_Organi_P15 — Groupe C — Lots 232 à 236 — 13 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 15 sur 30.

## Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

## Questions

### C-058 — Haute — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Fenêtre : LAMal : ce que l’assurance obligatoire des soins rembourse (lacune #0) ; LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #1) ; LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #4) ; LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › critères de qualité ANQ Les objectifs de participation sont atteints d (lacune #7) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #20) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #28) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #57) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #85) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › réadaptation psychosomatique (lacune #95) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › réadaptation psychosomatique (lacune #96)

**Contexte :** Le cours décrit l'indication de la réadaptation stationnaire (LAMal art. 39, liste hospitalière cantonale, garantie préalable de l'assureur après avis du médecin-conseil) et cite les profils de la réadaptation cardiaque (15.3.2011) et pulmonaire (2003) et les critères ST Reha et FMH BA.1–BA.8, non lus.

**Question :** Quels critères en vigueur en 2026 conditionnent la prise en charge LAMal de la réadaptation stationnaire et ambulatoire (art. 39 LAMal, OPAS art. 5 et 25, ST Reha, DefReha H+) et quelles sont les prestations minimales par type de réadaptation (cardiaque, pulmonaire, neurologique, psychosomatique, gériatrique, musculosquélettique) ? Quelles sont les versions actuelles des profils SCPRS (cardiaque) et de la Société suisse de pneumologie (pulmonaire) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-060 — Haute — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Fenêtre : LCR et OAC : aptitude à conduire et secret médical (lacune #3) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #39)

**Contexte :** Le cours cite la LCR (contrôle tous les deux ans dès 75 ans, art. 15d) et l'OAC, mais aucun délai suisse de reprise de la conduite après AVC.

**Question :** Quels délais de reprise de la conduite après AIT, AVC, infarctus et chirurgie recommandent la Société suisse de médecine légale (SSML, guide « Aptitude à la conduite ») et la Société suisse de neurologie, selon le groupe de permis (1 et 2), avec la version et l'URL ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-063 — Haute — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #29) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › (mécanisme) Anticorps IgG2 qui se lie à RANKL, essentiel à la formatio (lacune #30) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › (mécanisme) Anticorps IgG2 qui se lie à RANKL, essentiel à la formatio (lacune #31)

**Contexte :** Le cours suit la SVGO (cinq catégories de risque fracturaire) : ostéoanaboliques prioritaires en risque très élevé (tériparatide 24 mois, abaloparatide 18 mois, romosozumab à éviter après infarctus ou AVC récent) ; vitamine D 800–1000 UI/j, 50 000–125 000 UI avant Aclasta® ; spécialités suisses et doses des ostéoanaboliques et de la vitamine D, valeur normale de la calcémie non données.

**Question :** Quelle est la version la plus récente des recommandations SVGO/ASCO sur l'ostéoporose (année, comparée à celle du cours) ? Quelles spécialités suisses et doses existent

pour le tériparatide (Forsteo®, biosimilaires), l'abaloparatide (Eladynos®) et le romosozumab (Evenity®), avec conditions de remboursement LS, et pour la vitamine D3 ? Quelle calcémie (totale corrigée et ionisée) exiger avant denosumab et zolédronate ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-065 — Haute — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #40) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Interprétation 9.b : dépistage de la déglutition (lacune #41) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #42) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #43) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #44) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #45)

**Contexte :** Pour la réadaptation après AVC, le cours exige un dépistage de la dysphagie chez tous les patients sans nommer l'outil, et ne cite ni imagerie, ni électromyographie, ni recommandations suisses de prévention secondaire ou de rééducation.

**Question :** Quelles recommandations suisses (Swiss Stroke Society, SSN, SGNOR) ou européennes (ESO, EAN) fixent l'outil de dépistage de la dysphagie (GUSS, autre), l'évaluation instrumentale (FEES, vidéofluoroscopie), le traitement de la spasticité (toxine botulique, doses) et la prévention secondaire après AVC ischémique (antiagrégation, cibles LDL et TA) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-066 — Haute — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › syndrome coronarien aigu (lacune #46) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › insuffisance cardiaque (lacune #47) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #48) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #51) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #55) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #58) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè

(lacune #59) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Intensité d'exercice : ce que les sources permettent de dire (lacune #61) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #62) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Calendrier de surveillance (lacune #63) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #64) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #65) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #66)

**Contexte :** Pour la réadaptation cardiaque, le cours cite Cochrane et l'EAPC faute d'avoir lu l'ESC 2023 (SCA), 2021 (insuffisance cardiaque et prévention) et 2024 (syndromes coronariens chroniques) ; il ne donne ni classes de recommandation, ni intensité d'exercice, ni signes d'arrêt de l'effort, ni cibles LDL/TA, ni médicaments.

**Question :** Quelles classes de recommandation l'ESC 2023 (SCA), 2024 (SCC) et 2021/2023 (insuffisance cardiaque) donnent-elles à la réadaptation cardiaque ? Quelle prescription d'intensité (réserve de fréquence cardiaque, seuils ventilatoires, Borg) et quels critères d'arrêt de l'effort recommandent l'EAPC et la SCPRS ? Quelles cibles de LDL et de pression artérielle fixent l'ESC 2021/2024 et l'AGLA ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-068 — Haute — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #79) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #80) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #81) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #82) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #83) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › Fenêtre : le questionnaire mMRC (lacune #84) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #86) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #88) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #89) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › l'échelle de Borg (lacune #90) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #91) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #92) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #93)

**Contexte :** Pour la réadaptation pulmonaire, le cours suit GOLD (mMRC ≥ 2, VEMS/CVF < 0,7, $SpO_2$ ≤ 92 % → gazométrie) et l'ERS/ATS ; il ne donne ni seuil de désaturation à l'effort, ni critères suisses d'oxygénothérapie, ni libellé des degrés mMRC, ni limite inférieure du 6MWD, ni prescription chiffrée suisse, ni durée de l'effet.

**Question :** Quelle est la version la plus récente de GOLD (2026) et des recommandations de la Société suisse de pneumologie sur la BPCO et l'oxygénothérapie (critères $PaO_2$, désaturation à l'effort ≥ 4 % ou < 88 %) ? Quels sont les libellés des cinq degrés mMRC, la différence minimale cliniquement importante du 6MWD et l'intensité d'exercice recommandée (ERS/ATS 2023, Borg) ? Quels seuils de NT-proBNP orientent vers une insuffisance cardiaque (ESC) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée

dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-059 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Fenêtre : Code civil : capacité de discernement et représentation th (lacune #2)

**Contexte :** Le cours renvoie au Code civil pour la représentation dans le domaine médical sans reproduire l'ordre des représentants.

**Question :** Quel est l'ordre légal des représentants dans le domaine médical selon le CC 378 et comment s'applique-t-il pendant une réadaptation ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-061 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #5)

**Contexte :** Le cours donne le GAD-7 (0–21) avec un seuil optimisant Se 89 %, Sp 82 %, sans la valeur du seuil.

**Question :** Quels sont les seuils du GAD-7 (5, 10, 15) et du PHQ-9 et la valeur du seuil associée à Se 89 % et Sp 82 % dans l'étude de validation de Spitzer 2006 ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-062 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 236 Partie 1 DX.1 a

DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 31 229 patients Source. 68 cliniques ont transmis les données de 31 22 (lacune #14) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › comorbidité (CIRS) Définition. La Cumulative Illness Rating Scale cote (lacune #15) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › fracture de l'extrémité proximale du fémur (lacune #24) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #25) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › ANQ (Association nationale pour le développement de la qualité dans le (lacune #34) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #67) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #68) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › ANQ (lacune #78) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › réadaptation psychosomatique (lacune #97) ; LOT 236 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #121)

**Contexte :** Le cours utilise les chiffres ANQ 2024 (99 274 cas de réadaptation stationnaire dans neuf domaines) et SIRIS ; la part des patients prothésés, la mortalité après arthroplastie, l'incidence et la mortalité suisses de la fracture de hanche, la part de la réadaptation ambulatoire et celle de la faiblesse acquise en réanimation ne sont pas connues.

**Question :** Quelles sont les données suisses les plus récentes (OFS, Obsan, SIRIS, ANQ) sur l'incidence et la mortalité à un an de la fracture de hanche, la mortalité et les complications après arthroplastie, et le volume de la réadaptation ambulatoire ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-064 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › amplitude articulaire (lacune #13) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 29,8 % Définition. SIRIS enregistre la classe ASA (American Society of (lacune #16) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › peur de bouger (lacune #17) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › luxation (lacune #18) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › Oxford Knee Score (OKS) Définition. L'Oxford Knee Score est un questio (lacune #19) ; LOT 236 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #22)

**Contexte :** Pour la réadaptation après arthroplastie, le cours ne donne pas les amplitudes articulaires normales et cibles (flexion du genou), les classes ASA, l'échelle de peur du mouvement, la présentation de la luxation de prothèse ni le suivi radiologique.

**Question :** Quelles valeurs d'amplitude articulaire normales et cibles après prothèse totale de hanche et de genou, quelle définition des classes ASA (version 2020), quelle échelle de kinésiophobie (TSK-11/17, seuil) et quel suivi radiologique de prothèse recommandent les sources suisses ou européennes (Swiss Orthopaedics, EFORT) ? Quels signes cliniques signent une luxation de prothèse de hanche ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-067 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › toux inefficace (lacune #69) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › dysphagie après extubation (lacune #70) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #74) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Preuves et limites (lacune #75) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 🔍 Médicaments testés : aucune spécialité suisse recommandée (lacune #76)

**Contexte :** Pour la faiblesse acquise en réanimation, le cours cite le score MRC somme et la dynamométrie sans seuils chiffrés, une cible glycémique controversée sans chiffre et l'oxandrolone sans indication suisse.

**Question :** Quel seuil du score MRC somme (< 48/60) et de la dynamométrie définit la faiblesse acquise en réanimation ? Quelle cible glycémique recommandent l'ESICM et la SSMI ? L'oxandrolone est-elle autorisée en Suisse ? Quel dépistage de la dysphagie après extubation et de la toux inefficace recommandent les sources européennes ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

## C-069 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #109)

**Contexte :** Le cours traite la communication avec l'office AI (LAI art. 3b al. 3, 3c al. 4) sans avoir lu la portée du secret médical selon le CP 321.

**Question :** Comment le CP 321 et la LAI (art. 3b, 3c, 6a, 7d) articulent-ils la levée du secret médical lors d'une détection ou d'une intervention précoce AI, selon la version en vigueur en 2026 ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

## C-070 — Moyenne — LOT 236 · SSP O7.14

**Emplacement :** LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 236 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #118) ; LOT 236 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › test de marche de 6 minutes (lacune #119) ; LOT 236 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › 7.1 Syndrome de fatigue liée au cancer (lacune #120) ; LOT 236 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #122)

**Contexte :** Pour la réadaptation oncologique, le cours ne donne ni valeur de référence du 6MWT, ni liste des complications à exclure devant une stagnation, ni mécanisme de la fatigue, ni calendrier biologique sous AINS.

**Question :** Quelles recommandations suisses (Ligue suisse contre le cancer, SAKK, oncoreha.ch) ou européennes (ESMO 2020 sur la fatigue liée au cancer) fixent l'évaluation, l'exercice et le suivi en réadaptation oncologique, y compris la surveillance biologique sous AINS (créatinine, Hb) selon l'IP suisse ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

**Réponse :**

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P15 — 13 questions : C-058, C-060, C-063, C-065, C-066, C-068, C-059, C-061, C-062, C-064, C-067, C-069, C-070